

INSTITUIÇÃO: _____

DOC-DNAR-PRON-002
Rev. 01 / 2025

NOTA MÉDICA ESTRUTURADA

Decisão de Não Reanimação (DNAR) · Limitação de Suporte de Vida (LSV)

Planejamento Avançado de Cuidados (PAC) · Cuidados Paliativos

Proporcionais

■ DNAR — DO NOT ATTEMPT
RESUSCITATION — NÃO REANIMAR ■

Esta nota registra formalmente a decisão clínica de Limitação de Suporte de Vida (LSV) e Ordens de Não Ressuscitação (DNAR), conforme Conferência Familiar realizada e/ou avaliação clínica individualizada, em conformidade com CFM Res. 1.805/2006 e CEM Art. 41 § único.

A. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Paciente: _____ Nome completo _____

Prontuário nº: _____ DN / Idade: _____ / _____ / _____ | _____ anos Leito / Setor: _____

Diagnóstico principal: CID: _____ — _____

Comorbidades relevantes: _____

Data / hora da nota: _____ / _____ / _____ às _____:_____ h

Médico responsável (nome): _____

CRM: _____

B. AVALIAÇÃO CLÍNICA ATUAL (Snapshot do paciente)

B.1 Parâmetros Vitais e Funcionais

PARÂMETRO	VALOR ATUAL	TENDÊNCIA (↑ ↓ →)	OBSERVAÇÃO
FC (bpm)			
PA (mmHg)			
FR (irpm)			
SpO2 (%)			
SpO2 (%)			
GCS (E+V+M)			
RASS / Sedação			
Diurese (ml/h ou 24h)			
Suporte respiratório atual			
Pressores / drogas vasoativas			

B.2 Prognóstico Estimado e Critérios de Terminalidade

- Doença de base sem perspectiva curativa comprovada
- Progressão documentada apesar de tratamento otimizado
- Falência de múltiplos órgãos (MOF/MODS) em contexto irreversível
- Neoplasia avançada / metastática com ECOG ≥ 3 ou KPS ≤ 40%
- Dependência funcional total — acamado > 50% do tempo nas últimas semanas
- Incapacidade de alimentação oral / desnutrição grave refratária
- Score de prognóstico: PPS ≤ 30% | APACHE II ≥ ____ | SOFA ≥ ____
- Julgamento clínico do médico assistente: terminalidade provável em ≤ ____ dias/semanas
- Outro critério: _____

Síntese prognóstica livre (escrever em linguagem de prontuário):

C. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DECISÓRIA DO PACIENTE

A avaliação da capacidade decisória é obrigatória antes de qualquer decisão de LSV. O paciente com capacidade preservada tem autonomia plena sobre suas escolhas terapêuticas, incluindo recusa de tratamentos (CF/88 Art. 5º III · CC/2002 Art. 15 · CFM Res. 2.232/2019).

CRITÉRIO DE CAPACIDADE DECISÓRIA	PRESENTE	AUSENTE	PREJUDICADO
Compreende informações sobre diagnóstico e prognóstico	■	■	■
Processa as informações e relaciona consequências	■	■	■
Expressa preferências de forma consistente	■	■	■
Comunica uma escolha voluntária sem coação	■	■	■
Ausência de delirium / estado confusional agudo	■	■	■
Avaliação formal aplicada (Mini-Mental / GCS / MEEM)	■ Sim → escore: _____	■ Não aplicável	

- ■ CAPAZ → Decisão autônoma do paciente (registrar na Seção E)
- ■ INCAPAZ → Representante legal / família decide (Seção D + E)
- ■ ■ CAPACIDADE FLUTUANTE → Aguardar janela de lucidez / equipe decide

Justificativa da avaliação de capacidade:

D. REGISTRO DA CONFERÊNCIA FAMILIAR / REPRESENTANTE LEGAL

☐ ☐ Conferência Familiar realizada
(doc. PAC-LSV-001 arquivado no
prontuário)

☐ ☐ Decisão com representante
legal único — não houve conferência
formal

☐ ☐ Paciente decidiu
autonomamente — sem
necessidade de família

Data da conferência: / /

Horário: h às h

FAMILIAR / REPRESENTANTE	GRAU PARENTESCO	CPF	CONTATO	ASSINOU TERMO
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não

Síntese das decisões acordadas na conferência familiar:

☐ ☐ Unanimidade familiar

☐ ☐ Divergência registrada — ver
doc. PAC-LSV-001 Seção 7

☐ ☐ Comitê de Bioética acionado

E. ORDENS CLÍNICAS FORMAIS — DNAR / LSV

■ ATENÇÃO EQUIPE DE SAÚDE ■

As ordens abaixo foram estabelecidas após avaliação clínica criteriosa, conferência familiar documentada e/ou manifestação autônoma do paciente. Refletem ORTOTANÁSIA — conduta ética e legalmente amparada. NÃO constituem abandono terapêutico. Cuidados paliativos ATIVOS e MÁXIMOS continuam sendo prestados.

E.1 Medidas a NÃO INICIAR em caso de deterioração

INTERVENÇÃO	ORDEM	NÍVEL DE LIMITAÇÃO	FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA
Reanimação Cardiopulmonar (RCP) Massagem cardíaca externa · Desfibrilação	☐ NÃO INICIAR	DNAR Completo	PCR considerada evento terminal. RCP fútil no contexto clínico atual.
Intubação Orotraqueal (IOT) Ventilação Mecânica Invasiva (VMI)	☐ NÃO INICIAR ☐ Suspender se já em uso	DNAR + DNI	Ventilação invasiva não modificará prognóstico. Priorizar conforto respiratório.
Terapia Renal Substitutiva (TRS) Hemodiálise · HDVVC · DP	☐ NÃO INICIAR ☐ Suspender se já em uso	LSV — Renal	TRS não reverteria falência orgânica no contexto atual.
Internação em UTI Transferência para leito de cuidados intensivos	☐ NÃO TRANSFERIR ☐ Alta da UTI para cuidado paliativo	LSV — UTI	Internação em UTI não traz benefício proporcional ao ônus.

Drogas vasoativas (Noradrenalina · Adrenalina · Vasopressina)	■ NÃO INICIAR ■ Redução progressiva se já em uso	LSV — Hemodinâmico	Vasopressores não modificarão desfecho terminal.
Antibioticoterapia para infecções refratárias	■ NÃO INICIAR ■ Suspender antibiótico em uso	Conforme indicação paliativa	ATB apenas se controle de sintoma (ex: odor, dor). Não tratar infecção assintomática.
Alimentação artificial enteral/parenteral (SNE · SNG · NPT)	■ NÃO INICIAR ■ Suspender	Conforme conforto	Hidratação/alimentação mínima se promover conforto. Evitar sobrecarga hídrica terminal.
Hemotransfusões · hemoderivados	■ NÃO INICIAR ■ Conforme conforto	Conforme indicação paliativa	Transfundir apenas se aliviar sintoma (ex: dispneia por anemia grave).
Exames diagnósticos de alta complexidade (TC · RM · cateter · biópsia)	■ NÃO SOLICITAR ■ Suspender	Mínimo necessário	Apenas exames que impactem diretamente o manejo paliativo.
Outras medidas — especificar:	■		

E.2 Cuidados ATIVOS a MANTER / IMPLEMENTAR (Paliativos Proporcionais)

CUIDADO PALIATIVO ATIVO	ORDEM	PROTOCOLO / REFERÊNCIA
Controle de DOR (Escala NRS / VAS / Abbey · opioides titulados)	■ MANTER ■ INICIAR	Morfina 2–5 mg SC/EV q4h + resgate q1h PRN · Titulação conforme resposta
Controle de DISPNEIA (opioides em baixas doses + BZD se ansiedade)	■ MANTER ■ INICIAR	Morfina 1–2 mg SC q4h · Midazolam 1–2 mg SC se ansiedade · O2 se confortável
Controle de NÁUSEAS / VÔMITOS	■ MANTER ■ INICIAR	Haloperidol 0,5–1 mg SC q8h · Metoclopramida 10 mg SC q8h PRN
Controle de AGITAÇÃO TERMINAL / DELIRIUM	■ MANTER ■ INICIAR	Haloperidol 0,5–2 mg SC/EV · Midazolam 2,5–5 mg SC · Sedação paliativa se refratário
Controle de ESTERTORES TERMINAIS	■ MANTER ■ INICIAR	Hioscina (escopolamina) 0,5 mg SC q6–8h · Explicar à família
HIDRATAÇÃO paliativa	■ MANTER ■ SUSPENDER ■ Reduzir volume	SF 0,9% ou SG 5% — 250–500 ml/dia se confortável · Evitar sobrecarga
HIGIENE oral, pele e mucosas · Prevenção de UP	■ MANTER	Cuidados diários de enfermagem · Colchão pneumático · Reposicionamento q2–3h
ANALGESIA e SEDAÇÃO PALIATIVA (se sofrimento refratário)	■ Disponível se necessário	Protocolo institucional · Registrar indicação em nota específica · Família informada
SUPORTE EMOCIONAL / ESPIRITUAL ao paciente e família	■ MANTER	Psicologia · Capelania · Serviço Social · Visitas sem restrição de horário

COMUNICAÇÃO com família — atualização regular	MANTER	Contato a cada ____ horas · Responsável familiar: _____
--	--------------------------------------	---

F. NOTA NARRATIVA CLÍNICA — REGISTRO LIVRE (SOAP / PRONTUÁRIO)

Esta seção deve ser preenchida com a nota clínica completa, em linguagem de prontuário, descrevendo o raciocínio clínico que embasou a decisão de DNAR/LSV. É o texto mais importante juridicamente — escreva com clareza, precisão e sem abreviações ambíguas.

S — SUBJETIVO

Relato do paciente (se capaz) e/ou da família sobre sintomas, valores, desejos e preferências expressas:

O — OBJETIVO

Dados clínicos atuais: exames, sinais vitais, evolução das últimas 24–48h, resposta às terapêuticas empregadas:

A — AVALIAÇÃO

Análise clínica do médico: prognóstico, justificativa para a decisão de DNAR/LSV, ausência de indicação de medidas de suporte artificial de vida no contexto atual:

P — PLANO

Plano terapêutico definido: medidas ativas de cuidado paliativo, metas, próximas revisões, comunicação com família:

G. FUNDAMENTO ÉTICO-LEGAL DA DECISÃO

A decisão ora registrada fundamenta-se nos seguintes dispositivos, que conferem respaldo ético, deontológico e jurídico ao médico e à instituição:

◆ CFM — Res. 1.805/2006 (Ortotanásia)	Art. 1º
Ao médico é permitido limitar ou suspender procedimentos que prolonguem artificialmente a vida em fase terminal, respeitada a vontade do paciente ou seu representante legal.	
◆ CEM — CFM Res. 2.217/2018, Art. 41 § único (Vedação à Distanásia)	Art. 41 § único
Em doença incurável e terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações inúteis ou obstinadas.	
◆ CFM — Res. 2.232/2019 (Recusa Terapêutica)	Arts. 3º, 4º e 6º
O paciente capaz tem o direito de recusar procedimentos. O médico deve registrar a recusa no prontuário, cumprindo integralmente seus deveres éticos.	
◆ CF/88 — Dignidade da Pessoa Humana	Arts. 1º III e 5º III
Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. A dignidade é núcleo inviolável do direito à vida.	
◆ CC/2002, Art. 15 — Autonomia Corporal	Art. 15

Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica com risco de vida contra sua vontade.

◆ STJ — REsp 1.540.580/DF — Consentimento Informado como Excludente

STJ 2015

O consentimento livre, esclarecido e documentado constitui causa excludente da responsabilidade civil do médico diante de resultados adversos.

H. COMUNICAÇÃO COM A EQUIPE E REVISÃO DO PLANO

H.1 Comunicação Interna — Equipe Assistencial

MEMBRO DA EQUIPE INFORMADO	DATA/HORA	RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO	RUBRICA
Médico plantonista de retaguarda			
Enfermeiro responsável pelo paciente			
Equipe de enfermagem do setor			
Fisioterapeuta / Fonoaudióloga			
Psicólogo / Serviço Social			
Chefia médica / Direção clínica			
Outros:			

H.2 Sinalização no Leito e no Prontuário

■ ■ Pulseira / etiqueta

■ ■ Alerta DNAR no prontuário eletrônico

■ ■ Passagem de plantão documentada com DNAR

■ ■ Equipe de emergência interna notificada

H.3 Revisão e Validade da Ordem DNAR/LSV

Ordens de DNAR/LSV NÃO são permanentes e devem ser revisadas periodicamente ou diante de mudança clínica significativa, novo entendimento familiar ou solicitação do paciente.

Validade desta nota: _____ dias (até ____/____/____)

Próxima revisão programada: ____/____/____

Condições clínicas que implicam REVISÃO IMEDIATA desta ordem:

I. ASSINATURAS E VALIDAÇÃO

O(s) abaixo assinado(s) confirma(m) que a presente nota foi elaborada com base em avaliação clínica rigorosa, processo deliberativo adequado com paciente e/ou família, e em conformidade com as normas éticas e legais vigentes.

Médico Responsável Nome: _____ CRM: _____

Enfermeiro(a) Responsável Nome: _____ COREN: _____

Outro Profissional (se aplicável) Nome: _____ Registro: _____

Familiar / Representante Legal que tomou ciência desta nota:

Nome: _____ Parentesco: _____ Data/Hora: ____/____/____ h

Assinatura do familiar: _____

J. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES / NOTAS DE REVISÃO SUBSEQUENTES					
N.º	DATA / HORA	MOTIVO DA ATUALIZAÇÃO	MÉDICO (CRM)	MUDANÇA NA CONDUTA?	RUB.
1		Nota inicial — este documento		—	
2				☐ Sim ☐ Não	
3				☐ Sim ☐ Não	
4				☐ Sim ☐ Não	
5				☐ Sim ☐ Não	

NOTA CLÍNICA VÁLIDA A PARTIR DA ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL

Integra permanentemente o prontuário do paciente — NÃO REMOVER

DOC-DNAR-PRON-002 · Rev.01/2025
Gerado em 18/04/2026 às 23:35

Ref.: CFM Res. 1.805/2006 · CEM CFM Res. 2.217/2018 Art. 41 § único · CFM Res. 2.232/2019 · CF/88 Arts. 1º III e 5º III · CC/2002 Art. 15 · STJ REsp 1.540.580/DF